

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать
Индикатор	Доля обеспеченности лекарственными средствами пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением
2. Информация об организации	
Организация	Министерства здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель определяется как процентное соотношение объема бюджетных средств, выделенных из республиканского и местного бюджетов на амбулаторное лекарственное лечение в рамках ГОБМП и ОСМС на соответствующий регион или количество обеспеченных амбулаторных пациентов к объему бюджетных средств, выделенных из республиканского на амбулаторном уровне.
Основные понятия:	Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи - объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств; (Источник: Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»)
Обоснование и толкование	Роль лекарственного обеспечения существенна в сохранении и поддержании здоровья и поэтому вопрос качественного лекарственного обеспечения населения является наиболее приоритетным. Данный показатель важен для оценки обеспеченности диспансерных пациентов жизненно необходимыми лекарственными средствами. Недостаточное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне сдерживает развитие ПМСП. Мониторинг данного показателя в перспективе может способствовать определению текущих проблем и развитию стратегического плана по повышению обеспеченности населения лекарственными средствами.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Данные из информационных систем Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Информационная система «Лекарственное обеспечение»), данные уполномоченного органа и местных государственных органов управления здравоохранением

Методы сбора данных	Запрос в уполномоченный орган/ поиск данных в информационных системах МЗ РК
Единица измерения	% - процентное соотношение
Периодичность	Ежегодно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Показатель рассчитывается как процентное соотношение объема бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета на амбулаторное лекарственное лечение в рамках ГОБМП и ОСМС на соответствующий регион или количество обеспеченных амбулаторных пациентов к объему бюджетных средств. расчёт по объёму бюджетных средств Определение: показатель отражает степень обеспеченности пациентов, состоящих на динамическом наблюдении, через долю выделенных бюджетных средств, предусмотренных на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и ОСМС. Формула $\text{Доля обеспеченности (\%)} = \left(\frac{V_{\text{выделено}}}{V_{\text{потребность}}} \right) \cdot 100\%$ где: • $V_{\text{выделено}}$ — объём бюджетных средств (республиканский + местный бюджеты), выделенный региону на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов на динамическом наблюдении; • $V_{\text{потребность}}$ — общая потребность на республику/рассчитанная потребность региона в финансовых средствах для полного обеспечения данной группы пациентов. Расчёт по количеству обеспеченных пациентов Определение: Показатель отражает долю пациентов, состоящих на динамическом наблюдении, фактически обеспеченных лекарственными средствами. Формула $\text{Доля обеспеченности (\%)} = \left(\frac{N_{\text{обеспеченных}}}{N_{\text{всего}}} \right) \cdot 100\%$ где: • $N_{\text{обеспеченных}}$ — количество пациентов на динамическом наблюдении, получивших назначенные лекарственные средства в рамках ГОБМП и/или ОСМС; • $N_{\text{всего}}$ — общее количество пациентов, состоящих на динамическом наблюдении и подлежащих обеспечению.
Комментарии и ограничения:	Данный показатель ограничен в том, что не показывает реальную долю обеспеченности пациентов лекарственными средствами из-за отсутствия данных по количеству пациентов, нуждающихся в препаратах на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС, а показывает лишь обеспечение по объему бюджетных средств. В целях прозрачности и повышения

	достоверности показателя необходим анализ и первично необходимых заявок с учетом количества пациентов.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные для анализа доступны на информационных системах Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Информационная система «Лекарственное обеспечение»), данные местных государственных органов управления здравоохранением.
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по лекарственному обеспечению только на амбулаторном уровне. При этом не дезагрегированы по полу и возрасту пациентов.
7. Сопоставимость с международными данными/стандартами	Роль лекарственного обеспечения существенна в сохранении и поддержании здоровья и поэтому в странах ОЭСР вопрос качества и безопасности лекарственных средств поднят до уровня национальной биологической безопасности. В странах ОЭСР, в среднем 80% средств от общего объема финансирования лекарственного обеспечения направляется на обеспечение пациентов лекарственными средствами на амбулаторном уровне. В структуре государственных расходов на лекарственные средства доля амбулаторного лекарственного обеспечения в Казахстане занимает всего 55%. Недостаточное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне сдерживает развитие ПМСП и стимулирует избыточную госпитализацию в стационар. При этом, в странах-членах ОЭСР доля затрат на лекарственное обеспечение в общем объеме расходов стационаров не превышает 20%. В настоящее время в Казахстане данный показатель доходит до 50 %.
8. Ссылки и документация	file:///C:/Users/Dell/Desktop/densaulyk_2016-2020_0.pdf